

إِسْمُ الْمَرِيضِ رُبَاعِيًّا : عَائِدَةُ بَبَاوِي يَعْقُوبُ حَنَا

الحي / المدينة : المقطم

المحافظة : القاهرة

رقم البطاقة : 26404162400829 رقم التلفون : 01115398495

العمر(تاريخ الميلاد) : 16-04-1964 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي (-----)
المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157]

التعليق على التشخيص : -----

GR I-E
روستاقی کمیٹی
لڈی خنجر
موسیٰ حسین
صحة الایات الیضرفه
للحنه و مدیر

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم حمة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / د ----- / د ----- / د.ا ----- / د.ا

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جھة العلاج : --

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشئون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

Name: عايدة بباوي يعقوب حنا
National ID: 26404162400829



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

عايدة
بباوى يعقوب حنا

بلوك ١٢ - مدخل ٢ - اسكان المقطم
المقطم - القاهرة

٢٦٤٠٤١٦٢٤٠٠٨٢٩

IU0005823



Name: عايدة بباوى يعقوب		GUSTAVE ROUSSY	
MR. : 2938			
Detailed Medical Report			
			السيد
تخية طية وبعء,,			
		بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
		رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
		تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient has a history of right modified radical mastectomy performed in September 2022 following neoadjuvant chemotherapy, after which a port was placed and endocrine therapy was initiated. The patient subsequently presented with thyroid nodules; ultrasound and fine-needle aspiration cytology were suspicious for an oncocystic neoplasm, Bethesda category IV. A total thyroidectomy was performed on 3 September 2026, and pathology was pending at the time of the note. A chest CT demonstrated bilateral subcentimetric pulmonary nodules, the largest measuring 5 mm, for follow-up. The patient was on calcium supplementation (1 tablet × 1 × 90) and received one dose of zoledronic acid (Zometa) in the daycare pharmacy. Additional orders included Femara and a calcium supplement (1 tablet × 1 × 90) and a single dose of alpha-interferon. Pathology from the thyroidectomy revealed no malignancy. The patient continued Femara therapy, and a prescription for Femara was provided on the same day. The patient was prescribed Femara and supportive treatment for a planned duration of two months, with the pharmacy dispensing the medication accordingly. The patient underwent a CT of the chest, abdomen, and pelvis, which confirmed the previously noted right-sided findings. Full laboratory studies were reviewed, and Femara was continued for an additional three-month course.			
تحريرا في ,			
		التاريخ : 20-09-2026	الوقت :
		مايكل جمال فوزى	الطبيب المعالج :
يعتمد ,			



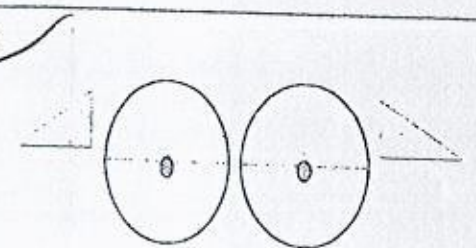
مملكة العربية السعودية
وزارة الصحة العامة
إدارة صحة المرأة المصرية



MDT FORM

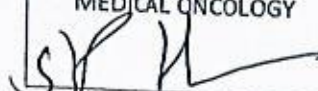
18/10/2022

Name	علاء عبد الوهاب	MRN	
Age	45	ID	Cor C-C
Menopausal status		Phone	0110298890
OCP		marital status	divorced
Co morbidity	DM, HTN	Family history	C 78.5 1752-A 9

Bx: IDC grade II				Clinical Data	
ER: +ve 8/8	PR: +ve 9/8	HER 2: -ve	Ki67: 30%		
Sonomammography: post MRM free margins, free nipple area on LN → 3/16 T2 M1					
Mets Workup: for post op. MDT				CTNM 3 1	
Recommendations: ypT2 ypN1 (Partial response) neoadjuvant → Tumor markers					

MDT OUTCOME & PLAN

PORT, adjust hormonal tht A.T
for 5-7 yrs, bone den DEXA 12 months

MEDICAL ONCOLOGY	SIGNATURE		
	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
18/10/2022		Dr. R. A. A. 18/10/2022	



Patient Name : الأستاذة / عائدة بيباوى يعقوب :	Request No. : 13005486
Patient No. : 26404162400829	Request Date : 24/09/2022
Path No. : 2807/22	Verification Date : 12/10/2022
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Age : 58 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer post NACT .

Nature of the specimen:

Right breast & Right axilla (MRM)

Gross Examination:

• Procedure: Right MRM

measured 18x11x5 cm with covering skin ellipse measured 12x8 cm .

• Tumor extent : A greyish white tumour bed site

• Size: 2.5 x2.5 cm .

• Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .

• Distance from margins: 8 cm away from deep margin , 4 cm away from the skin .

• Lymph nodes number and size: 16 L.Ns up to 2x2 cm .

Microscopic examination:

• Histological type: Residual tumor of invasive duct carcinoma (Actual tumour size 1x1 cm ,
Cellularity 10%)

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

• Ductal carcinoma in situ: No

• Skin involvement: Free nipple and areola

• Lymph node involvement: 3/16 L.Ns , no extranodal invasion

• Resection Margins: Free margins

• Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Diagnosis:

Right MRM (post NACT) :

Invasive duct carcinoma grade II (Actual tumour size 1x1cm)

• Free margins

• Free nipple and areola

• Free L.Ns (3/16)

• Pathologic partial response

Verified by :

saamah sayed

خطابات أورام



NUCLEAR MEDICINE UNIT

وحدة الطب النووي

Patient Name: Aida BBawy Yakoub

Date: 27/3/2022.

^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP:

Report:

- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.
- Degenerative changes are noted in the dorso-lumbar vertebrae.
- Both kidneys are seen

Conclusion:

- *No definite evidence of metastatic osseous deposits.*

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit

Sherien Mahdy, M.D

Huda Fathy, MD

aida Babawi Yaqub Hana

026-08-26

Prof. Dr. no doctor

Goustave Roussey International Egypt

ST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, BDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA underwent right MRM.

I- CHEST:

- Multiple bilateral scattered pulmonary nodules largest measuring 8.5 mm at the right upper lobe.
- No pulmonary masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- Bilateral elastofibroma dorsi.
- Small hiatus hernia.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. Small right hepatic lobe segment VI hypodense focal lesion measuring 13 x 7.9 mm. No dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal size, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Multiple axial and appendicular skeleton scattered lytic and sclerotic bone lesions.

Patient's Name:

Aida Babawi Yaqub Hana

Date:

2026-08-26

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Opinion:

- ❖ Multiple bilateral scattered pulmonary nodules for PET-CT study.
- ❖ Right hepatic lobe focal lesion for dynamic MR study.
- ❖ Multiple axial and appendicular skeleton lytic and sclerotic bone lesions for bone scan.

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy

aida Babawi Yaqub Hana

026-08-26

Prof. Dr. no doctor

Goustave Roussey International Egypt

ST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, BDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA underwent right MRM.

I- CHEST:

- Multiple bilateral scattered pulmonary nodules largest measuring 8.5 mm at the right upper lobe.
- No pulmonary masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- Bilateral elastofibroma dorsi.
- Small hiatus hernia.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. Small right hepatic lobe segment VI hypodense focal lesion measuring 13 x 7.9 mm. No dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal size, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Multiple axial and appendicular skeleton scattered lytic and sclerotic bone lesions.

Patient's Name:

Aida Babawi Yaqub Hana

Date:

2026-08-26

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Opinion:

- ❖ Multiple bilateral scattered pulmonary nodules for PET-CT study.
- ❖ Right hepatic lobe focal lesion for dynamic MR study.
- ❖ Multiple axial and appendicular skeleton lytic and sclerotic bone lesions for bone scan.

Dr.sherif Wagdy

Dr.sherif Wagdy